本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

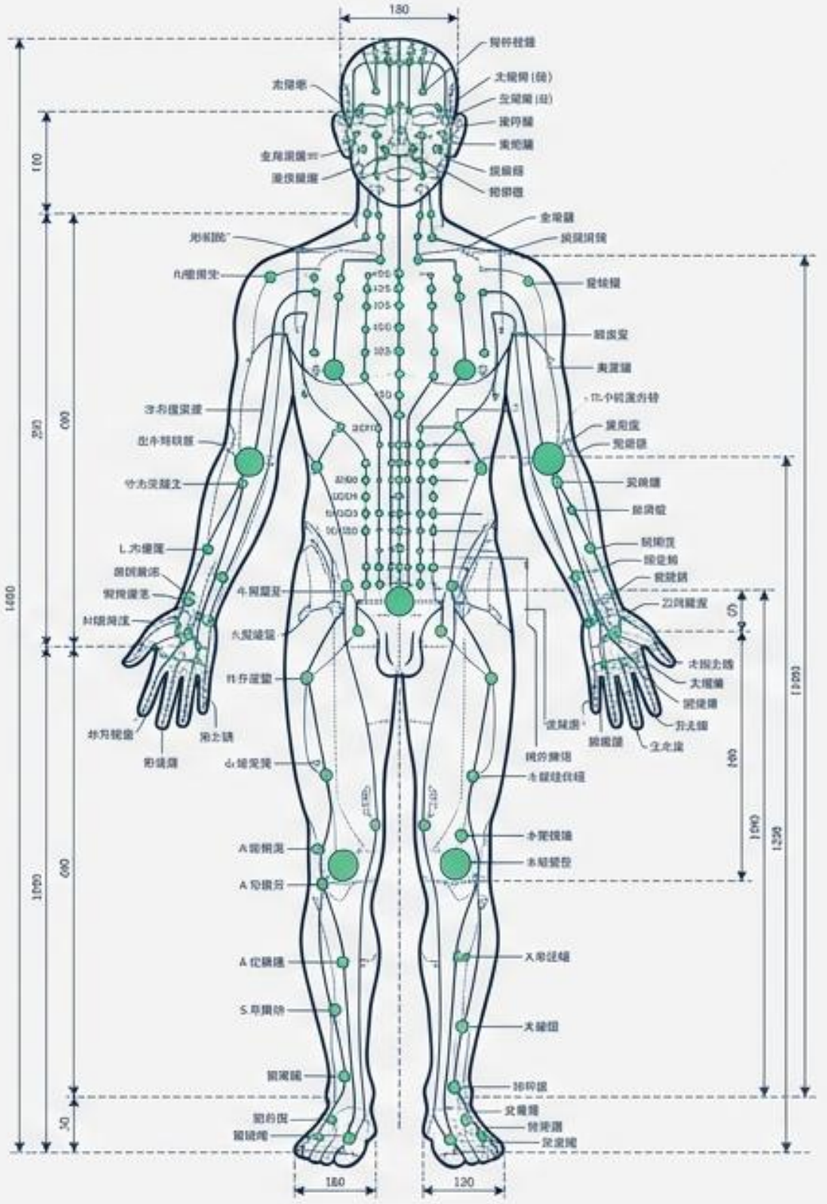
异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



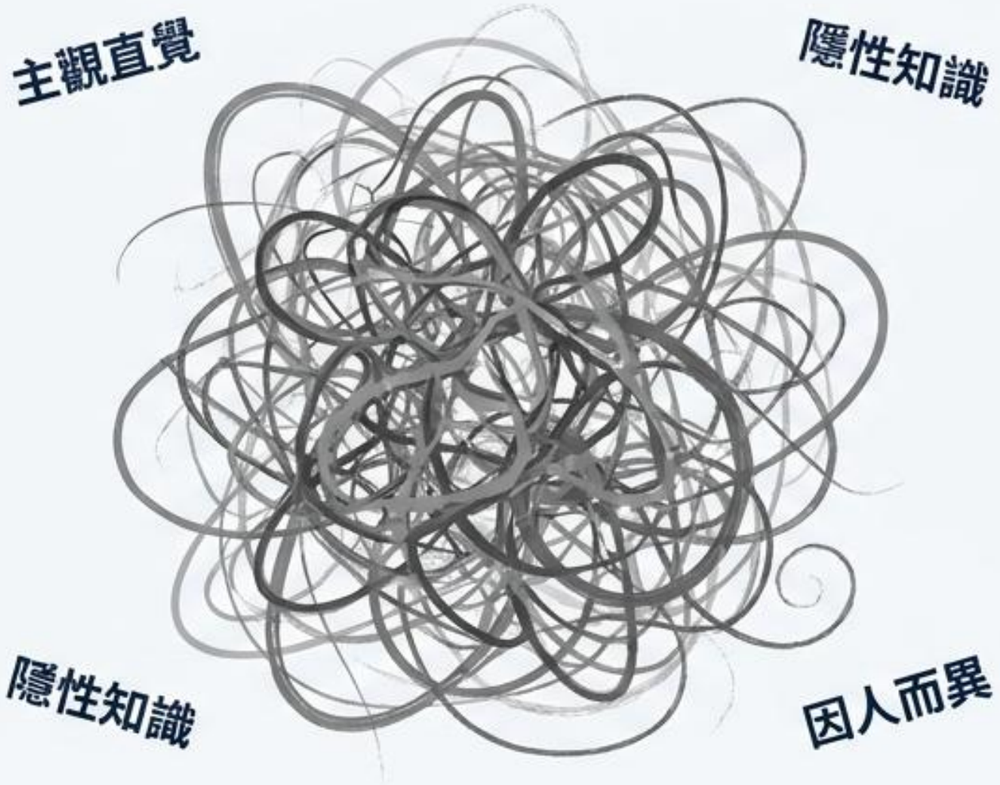
AI 中醫大腦系統：
系統架構解密與臨床導入指南

基於 Mind AI 平台 × 本形學 (Ontypology)
驅動的透明化辨證論治引擎

【可檢核】 【可推演】 【可回溯】



傳統心法的經驗暗箱



AI 輔助的透明推理鏈



中醫不需被重新發明，只需被精準解碼。AI 不是取代醫師，
而是將千年的智慧「形化（Type-Izations）」，讓每一次辨證都有據可查。

MIND AI

系統定位與邊界：輔助決策的精密儀表板

【執業中醫師】臨床輔助

四診結構化、方藥檢核。
邊界：不直出處方，醫師擁有最終簽署權。

【中醫學員】教學訓練

辨證思路演練、錯因對照。
邊界：不可用於真實診療。

【研究者】資料工程

醫案結構化、規律萃取。
邊界：僅供假設生成。

【養生使用者】體質辨識

體質辨識與治未病。
邊界：嚴禁診療行為。

【醫療安全絕對紅線】AI 中醫大腦為輔助工具。
急危重症第一優先為轉診；所有診療方案皆須經人類醫師覆核簽署。

MIND AI

底層語法：將萬物形化（Type-Izations）的三大數學容器

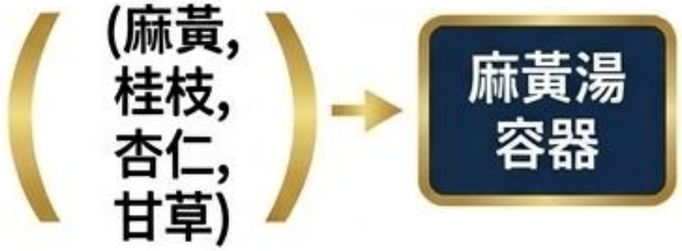
集合 SOM

同現屬性值的集體歸納。
中醫映射：證候集合。



容器

有邊界的容納關係。
中醫映射：處方藥味與經脈穴位。



抽象

由具體上升為一般原則。
中醫映射：證型推導至治則。



MIND AI

雙向映射引擎：方證對應的工程化實現

【由方測證】
太陽中風證
(SyndromeType)
SOM

- 發熱（權重2）
- 惡風（權重3）
- 汗出（權重3）
- 脈浮緩（權重3）

雙向映射引擎確保君藥直指主證，且方劑總功效無縫覆蓋證候全集。

【由證出方】
桂枝湯
(FormulaType)
BOM

君：桂枝

臣：白芍

佐：生薑 / 大棗

使：甘草

MIND AI

絕對硬閘門：交集判準 ∩(T) 與灰區管理

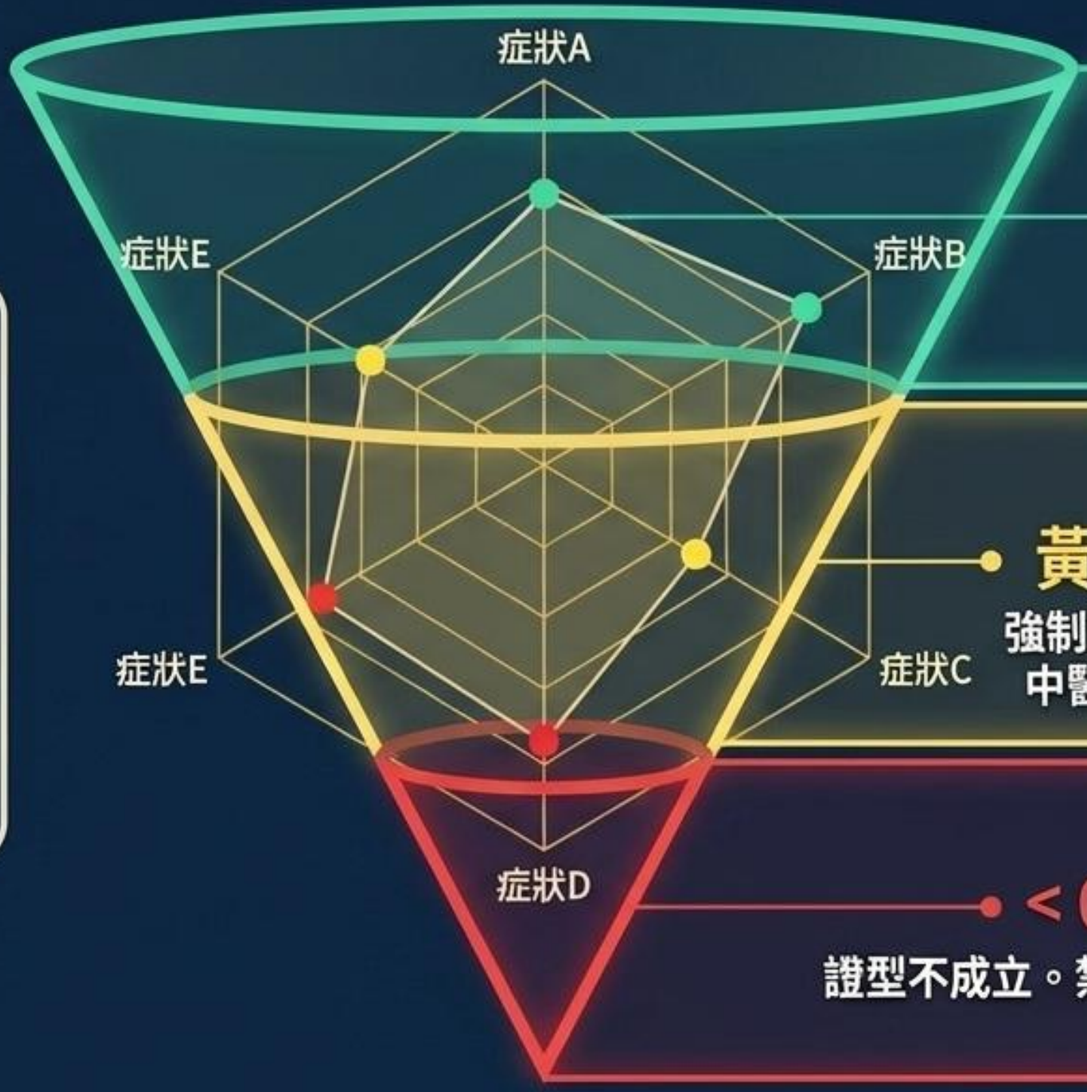
患者症狀集 P

∩

系統判準集 T

=

量化吻合度



≥ 0.85

綠燈：證型確立

進入治則推導。徹底杜絕 AI 拼湊成方的幻覺。

0.70 - 0.84

黃燈：證型傾向 (灰區)

強制並列次選證型，標注鑑別要點。中醫疑似之間的特性，不是缺陷。

< 0.70 **紅燈：退回重辨**

證型不成立。禁止強行出方，退回重新辨證。

MIND AI

TDDT 引擎：形驅動辨證論治 8 大工作流



上一步的**輸出規格**，就是下一步的**硬性輸入**。資訊傳遞並非文字，
而是嚴格定義的「**形實例（Type Instances）**」。

MIND AI

Phase I：資訊形化與絕對客觀 (S1-S2)

S1 四診採集官 (SymptomType)

1. 紀律：只記錄、不判斷
2. AI 處理矩陣：

部位	性質	程度	時律	誘因

3. 【缺口清單機制】未採集資訊顯式標注，嚴禁 AI 腦補或編造體徵。

S2 八綱定位官 (Eight Principles)

1. 紀律：每綱判定必附 2 項以上指標
2. AI 處理器：
   逐綱判定
   表裡 / 寒熱 / 虛實 / 陰陽

3. 【矛盾保留機制】矛盾證據顯式保留（如表寒裡熱夾雜），不強行簡化病情。

MIND AI

Phase II：多體系推演與治法錨定 (S3-S4)

S3 辨證推理官 (SyndromeType)

1. 輸入：八綱定位表 + 四診屬性表
2. 處理：自動切換 臟腑 / 六經 / 衛氣營血。
   強制並行推演 ≥ 2 個候選證型。
3. 覆核：檢視鑑別排除理由（如：太陽中風 vs 傷寒的汗出鑑別）。

∩
(T) 閘門過濾

S4 治則確立法官 (PrincipleType)

1. 輸入：確立之證型實例
2. 處理：推導標本緩急與八法。
3. 覆核：驗證【證 -> 法推導鏈】。
   每一條治法必須能回指具體證候，禁止經驗性堆疊。

MIND AI

Phase III：結構化處方與安全檢核 (S5-S6)

S5 方藥設計官 (FormulaType BOM)

依方證對應選方，劃分君臣佐使，安排劑量。

【紅線檢核】

- 十八反、十九畏逐對掃描
- 孕產婦禁用藥自動攔截
- 毒性藥（如附子）劑量與炮製檢核

命中即亮紅燈並中止出方。

S6 針灸外治官 (AcupointType)

循經取穴、局部取穴、特定穴配伍。

【刺灸禁忌掃描】

- 孕婦三陰交、合谷等禁刺掃描
- 小兒囟門禁忌
- 確認補瀉手法與虛實方向一致

MIND AI

Phase IV：時間本形與自我演化 (S7-S8)

S7 療效演化官 (時間維度)

複診逐屬性前後對照 (好轉/未變/加重)。遵循「效不更方」的時間智慧。

執行危急警訊掃描，命中即觸發轉診。

S8 知識沉澱官 (群體智慧)

醫案去識別化七段入庫。當療效與預測發生偏差，AI 生成「∩(T) 權重精進提案」或「鑑別要點補充」。

提案預設為「不生效」，須經醫師委員會審核通過，防止知識庫污染。



MIND AI

典範轉移：傳統經驗心法 vs. 形驅動辨證 (TDDT)

[傳統模式] 個人經驗心法		[AI 中醫大腦] 形驅動辨證 (TDDT)
資訊採集	個人主觀記錄，易有遺漏	結構化屬性表，空缺顯式標注，防範臆想
辨證推演	依賴單一憑直覺，難以覆盤	多體系平行推演，∩(T) 量化計分與灰區並列
方藥設計	經驗堆疊，禁忌查核耗時	君臣佐使 BOM 結構，毫秒級十八反與孕婦紅線檢核
經驗傳承	隱性知識，因人而異，難以傳授	全程形證據鏈留痕，提案式審核，打造機構群體大腦

MIND AI

醫療安全防護網：四層準確性保證機制



第一層：∩(T) 硬閘門
證候與判準的數學吻合度，
杜絕弱吻合強行出方。

第二層：邏輯骨架推理
確保「證 -> 法 -> 方 -> 藥」每一步
皆可可回指，防堵 AI 邏輯跳躍。

第三層：人類醫師覆核
文獻比對，強制執業醫師簽署，
確立人機邊界。

最外層：形證據鏈留痕
輸入、輸出、判準版本與時間戳記
全程封存。可回溯、可審計、可複現。

MIND AI

絕對紅線：危急警訊與斷路器機制

【用藥斷路器】
當 S5 處方觸發「十八反/十九畏」或孕產婦命中「禁用本草 (如水蛭、虻蟲)」，系統立即鎖死出方。

【急症斷路器】
當 S7 掃描到「神昏譫語、胸痛徹背、高熱驚厥」等危急徵象，中止辨證，強制彈出【即時轉診 120 / 急診】指引。



【用藥斷路器】
當 S5 處方觸發「十八反/十九畏」或孕產婦命中「禁用本草 (如水蛭、虻蟲)」，系統立即鎖死出方。



【不確定性降級】
涉及毒性藥 (如附子)、兒科、術後等高風險情境，強制將 AI 決策降級為「僅供參考」，升級人工主導權限。

MIND AI

科技與傳承的終極協同

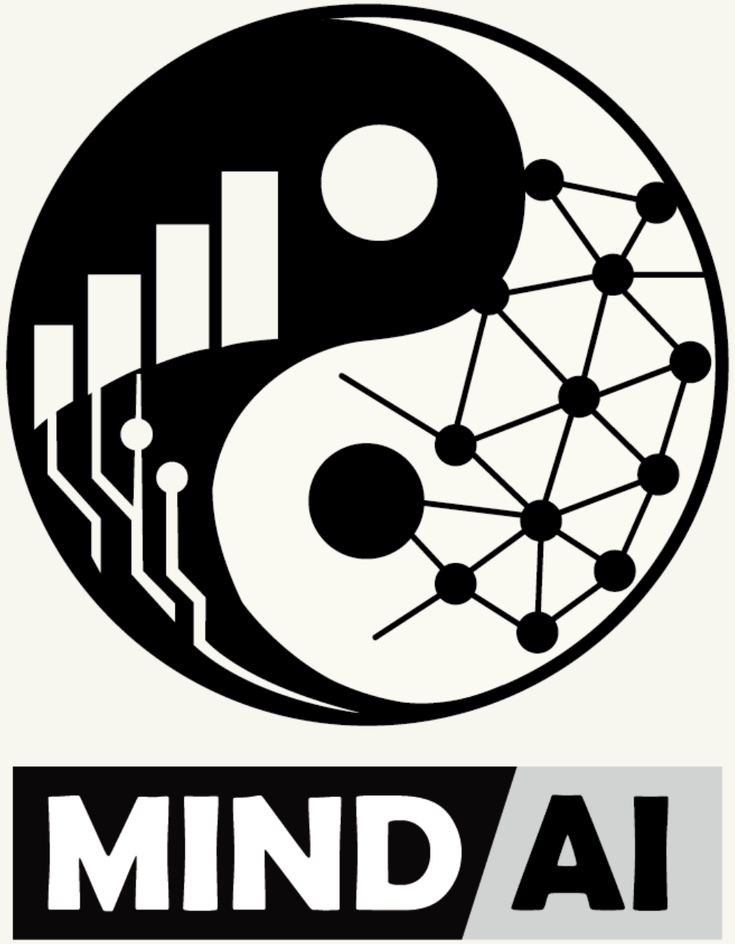


“AI 中醫大腦的責任，是把不確定性說清楚、
把證據擺完整、把紅線看牢靠——然後，
將最終的診療決定權，交還給人類醫師。”

透明 (Transparent) · 可溯 (Traceable) · 可教 (Teachable)

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com